

3

PREGUNTAS A ESPECIALISTAS

// ABORDAJE DEL ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES.**DRA. SILVIA ONGINI***

Especialista en Psiquiatría Infantojuvenil - UBA. Residencias Médicas en Pediatría y Neonatología.
Psiquiatra Infantojuvenil del Departamento de Pediatría, Hospital de Clínicas José de San Martín - UBA.
Presidenta de CePasi, Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada a prevención, detección y atención de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de abuso sexual.

// TRATAMIENTOS DE EMERGENCIA EN ABUSO SEXUAL.**DRA. MIRIAM CALVARI***

Pediatra Infectóloga. Secretaria del Comité Nacional de Infectología - SAP.
Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba.
Miembro del Comité de contralor de Infectología Pediátrica del Consejo de Médicos de Córdoba.

// DR. EDGAR DANIEL PIEDRA*

Pediatra Infectólogo. Secretario del Comité de Infectología SAP. Córdoba.
Servicio de Infectología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba.

// COORDINADORA**DRA. VIRGINIA I. ORAZI**

Médica Pediatra. Servicio de Pediatría Hospital B. Houssay. Provincia de Buenos Aires.
Responsable Docente de la UDH de Pediatría de la UBA y Titular de la Cátedra de Pediatría de la UCES. Hospital B. Houssay.
Integrante del Equipo del PRONAP.

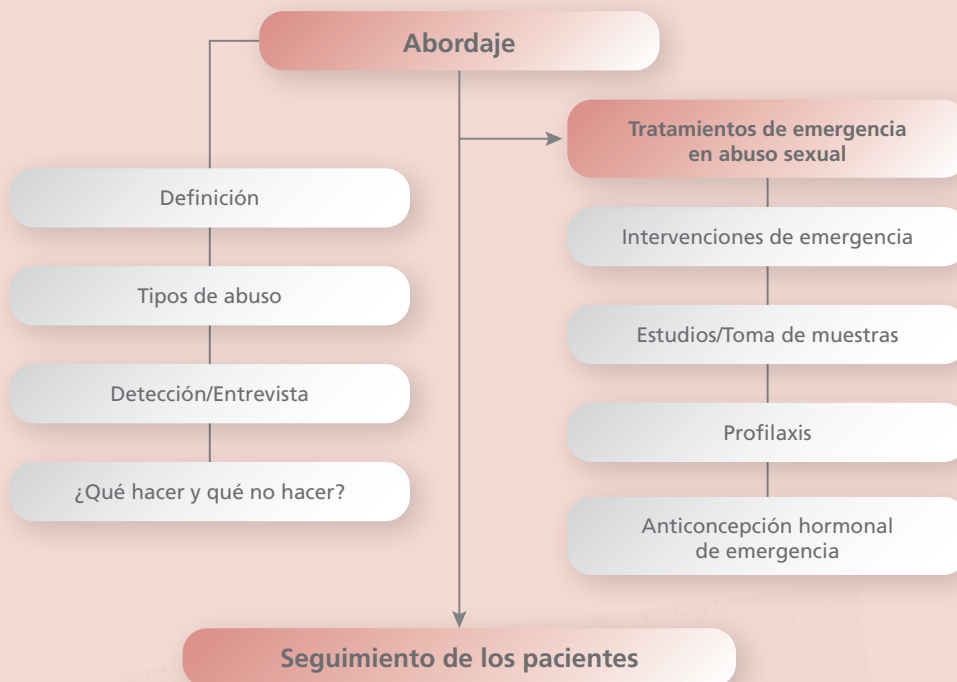
* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

OBJETIVOS

- ◆ Definir qué se entiende por abuso sexual y describir los diferentes tipos de abuso.
- ◆ Detectar si un/a adolescente está sufriendo abuso sexual sin victimizarlo y protegiendo sus derechos.
- ◆ Efectuar las intervenciones de emergencia: solicitar estudios, realizar profilaxis e implementar anticoncepción hormonal.
- ◆ Realizar el seguimiento de los pacientes.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Abordaje del abuso sexual en adolescentes



INTRODUCCIÓN

Hacia fines de la década del 70 se comenzó a estudiar seriamente el impacto de la violencia sexual en niños y adolescentes. Hoy contamos con abundante bibliografía que da cuenta desde los cambios subjetivos y vitales hasta los neurobiológicos, además de los efectos cognitivos y la relación innegable con manifestaciones clínicas.

Según la **OMS**, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Sin embargo, un trabajo publicado recientemente por el *Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)* de USA con víctimas de hasta 25 años, indica que la proporción sería 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 varones, quienes habrían sufrido alguna forma de abuso sexual antes de los 18 años.

En la **Argentina**, no se cuenta con estadísticas oficiales ni registros unificados sobre los casos de abuso sexual. Según datos de la *Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2020* reportan que 1 de cada 10 mujeres adultas, de 18 a 49 años, declara haber sufrido violencia sexual durante su niñez.

Un análisis del *Programa Las Víctimas Contra Las Violencias año 2020-2021* del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informa que el 57,8% de las víctimas registradas por violencia sexual eran NNyA, en todos los grupos etarios, el mayor porcentaje pertenece al género femenino, representando casi 4 veces más que el masculino. El 81,1% de los agresores eran de género masculino y en el 74,2% de los casos, del entorno cercano de la víctima.

Pero los datos con los que contamos son apenas la punta del iceberg. La falta de cifras evidencia lo invisibilizada que está aún esta problemática en nuestra sociedad. Es fundamental que los profesionales de la salud estemos interiorizados no solo de las manifestaciones, los protocolos y buenas prácticas frente a un caso sino también del marco legal que nos involucra en la protección de las víctimas.

El abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una de las formas más graves de violencia y conlleva efectos devastadores en la vida de quienes lo sufren. En el ámbito familiar es el tipo de maltrato infantil menos denunciado.

ABORDAJE DEL ABUSO SEXUAL EN ADOLESCENTES

¿Qué se entiende por abuso sexual en la adolescencia?

Hablamos de abuso sexual contra adolescentes cuando se los involucra en actividades sexuales para las cuales están evolutivamente inmaduros y no están en condiciones de consentimiento.

En otras palabras, es la intromisión de la sexualidad adulta en el cuerpo y el psiquismo de chicas y chicos. Es importante aclarar que **no son comportamientos consensuados** aun cuando el adolescente no se resista, ya que este tipo de violencia incluye tanto el coaccionar o forzar, como la persuasión.

Muchas veces los abusos se inician antes de llegar a la adolescencia, pero se detectan recién en esa etapa, ya sea por un indicador directo (embarazo o una infección de transmisión sexual, por ejemplo) o porque él o la adolescente pueden develarlos. El detonante para lograr poner la violencia en palabras puede ser el que se establezca un vínculo de confianza con un par o el sentir que pueden liberarse del vínculo abusivo.

En la inmensa mayoría de los casos, **los agresores son parte del entorno familiar y social próximo** de los adolescentes que son víctimas, lo que dificulta la intervención. Estamos hablando de padres, abuelos, tíos, hermanos, pero también de madres, abuelas o hermanas, entre otros vínculos cercanos. Al contrario de lo que pensamos, el hogar está lejos de ser el sitio más seguro para muchas adolescencias.

Aunque las **estadísticas muestran que la mayoría de los abusos son perpetrados por varones, también hay mujeres que los cometen**. Por distintos motivos, como la construcción en torno al género y la idealización de la figura materna como una de cuidado incondicional, estos casos suelen quedar invisibilizados y la detección ser más difícil, lo que hace que la violencia pueda prolongarse aún más en el tiempo.

Por otro lado, las representaciones imaginarias, donde las mujeres delinquentes sexuales están significativamente subrepresentadas, (las cifras dan cuenta entre el 5 y 10% de los casos de abuso) podrían vincularse a que el imaginario social que construimos conecta a la violencia con la fuerza física y el descontrol, características netamente masculinas. Las mujeres en general y más específicamente las madres, tienen más libertad que los hombres para tocar a sus hijos. Por lo tanto, un hombre puede ser percibido más fácilmente como abusivo cuando toca a un adolescente que cuando una mujer lo hace de manera similar.

En este encuadre, la imagen femenina asociada a una figura “angelical”, “protectora” y “frágil” no coincidiría con el estereotipo anteriormente descripto. En cuanto al impacto traumatogénico, o sea la capacidad de generar un trauma, en las víctimas, es más grave, en general, cuando el abuso reviste estas características.

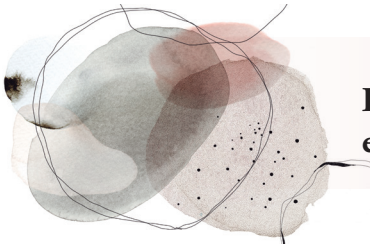
El abuso sexual se constituye siempre como un vínculo depredador que se apoya sobre uno previo de amor, confianza y dependencia, provocando que a las chicas y los chicos les cueste reconocerse como víctimas. Por el impacto que tiene en la subjetividad y en la psiquis en desarrollo, consideramos que podría equipararse a la tortura.

Esa situación traumática sostenida en el tiempo y sin un tratamiento adecuado va a ocasionar daños neurobiológicos, subjetivos y vinculares que se van a expresar en todos los aspectos de su vida. No debemos perder de vista que estamos hablando de un adolescente que es cosificado por quien debería estar amándolo, cuidándolo y dándole un sentido subjetivo.

¿Qué tipos de abuso hay?

Para entender mejor cómo los abusos se instalan de distintas formas, podemos diferenciarlos en:

Con contacto físico	• Los manoseos y frotamientos están entre los más frecuentes, como así también los besos sexuales en los genitales, zona anal o pechos de las chicas y los chicos. • El incitarlos a que realicen esas conductas a los adultos, por encima o por debajo de la ropa. • El coito interfemoral (entre los muslos), la penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal con dedos, objetos o miembro masculino.
Sin contacto físico	• Comentarios sexualizados hacia el adolescente. • Indagaciones inapropiadas acerca de su intimidad sexual. • El exhibicionismo (por ejemplo, cuando el agresor muestra sus genitales). • El exponerlos a pornografía. • Instar a que adolescentes tengan sexo entre sí, filmarlos o fotografiarlos en poses sexuales o desnudas (producción de material de explotación sexual). • Inducción a que el adolescente se desnude o masturbe frente al agresor. • Contactar a un adolescente por internet con propósitos sexuales (grooming).



La inmensa mayoría de las veces los abusos no dejan marcas en el cuerpo.

El prejuicio de que la violencia sexual se da únicamente cuando hay penetración atraviesa toda la sociedad, incluso a algunos profesionales de la salud. También existe la creencia de que algunas conductas implican “un poquito” y otras “un gran” abuso. Esto es falso. El abuso es siempre abuso y en todos los casos se va a inscribir en el psiquismo de una determinada manera.

¿Qué ocurre cuando quien tiene conductas abusivas, es otro niño o adolescente?

La violencia sexual contra adolescentes no es solamente ejercida por parte de adultos, sino que también puede darse entre chicos, entre un adolescente y un niño de menor edad, entre adolescentes.

De hecho, según las estadísticas, **entre un 20 y un 40% de las NNyA que son víctimas, son abusadas por niños mayores, adolescentes y jóvenes con menos de 21 años.**

Pero **Estados Unidos en 2019**, un estudio publicado por David Finkelhor (Sexual abuse and assault in a large national sample of children and adolescents), reveló que más del 70% de los abusos sexuales son cometidos por otros jóvenes o adolescentes. La mayoría de los abusos sexuales fueron cometidos por otros jóvenes (76,7% en el caso de los hombres 70,1% en el caso de las mujeres). Mayoritariamente perpetrados por alguien cercano y conocido. Las mujeres son mayoritariamente abusadas por hombres (88,4%). Los hombres son abusados por otros hombres

(45,6%) y por mujeres (54,4%). En el 15% de los casos, el abuso ocurrió con penetración. Entre los jóvenes de 10-17 años, el 66% reveló no haber reportado el incidente ni a los padres ni a otro adulto. De todos los casos evaluados, **únicamente el 19,1% fue reportado a la policía.**

En estos casos, también se da una asimetría de poder ya sea en términos de fuerza física, económicos, emocionales, sociales o en relación con la diferencia de edad, roles o capacidad de manipulación psicológica.

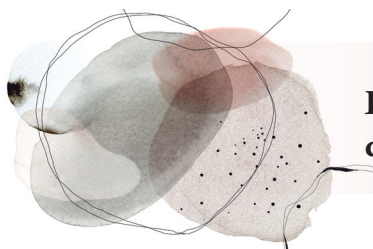
Muchas veces –aunque no todas– es probable que los chicos y las chicas que tienen conductas abusivas estén reeditando de forma defensiva un abuso sufrido por ellos mismos o ejercitando un abuso de poder manifestado en el escenario de la sexualidad. Tener esto en cuenta no implica minimizar el hecho.

En todos los casos, además de que existan programas de prevención, **es clave la detección temprana y el tratamiento** para que ese patrón de conducta –el valerse de la asimetría de poder para ejercer la violencia sexual sobre otro– no se cristalice en el niño o adolescente como una identidad en su vida adulta.

Pedir la intervención de la Justicia también es fundamental. La intervención es a las Defensorías y según la edad también a fiscalía especializada, el adolescente tiene derecho a recibir tratamiento y acceso a la justicia.

¿Cómo detectar si un adolescente sufrió abuso o lo está sufriendo actualmente?

La violencia sexual puede expresarse de varias formas. Como las luces de un semáforo, estas manifestaciones nos alertan de que algo está pasando.



El relato es el indicador más específico con el que contamos y debería ser siempre suficiente.

De hecho, muchas veces su palabra es la única evidencia con la que se cuenta, ya que a diferencia de lo que ocurre con otros delitos y formas de violencia, no suele haber testigos ni marcas en el cuerpo. Por esto es tan **importante preservar ese relato y no contaminarlo con preguntas inadecuadas que pueden confundir o culpabilizar a la víctima.** Sin embargo y tal como dijimos, muchos no logran poner el abuso en palabras y lo manifiestan a través de sus comportamientos.

Las señales más evidentes:

A) Manifestaciones físicas

Cuando existen, suelen ser suficientes para evidenciar el abuso, pero en la gran mayoría de los casos no se presentan. Debemos recordar, además, que hay abusos que ocurren sin que haya contacto físico, como por ejemplo cuando se expone a las adolescencias a pornografía o al exhibicionismo.

En el caso que los abusos impliquen contacto físico y que existan manifestaciones físicas, estas pueden ser:

Embarazo	En Argentina , de acuerdo con nuestro marco jurídico, la edad mínima de consentimiento sexual es 13 años (así lo establece el artículo 119 del Código Penal). Antes de esa edad, se debe hablar siempre de abuso sexual y no de “relaciones sexuales consentidas”. Sin embargo, según el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo embarazo por debajo de los 15 años puede considerarse producto de un abuso.
Dolor al sentarse o al ir al baño	Esto puede provocar cambios en la forma de caminar.
Manchas en la ropa interior	Puede notarse por sangrado, irritación o lesiones en las áreas genital o anal.
Infecciones genitales o de transmisión sexual	Son siempre diagnosticadas por un médico que suele sospechar, por la presencia de síntomas como prurito, flujo, mal olor o manchas en la ropa interior.
Conductas hipersexualizadas	Es una forma de expresión específica pero no exclusiva del abuso sexual. Se trata de una serie de comportamientos que muestran que ese adolescente puede estar experimentando o teniendo algún tipo de conocimiento de la sexualidad adulta que de otro modo no tendría. Es una erotización que excede la curiosidad por los genitales propia de la etapa vital que atraviesa. La conducta hipersexualizada más frecuente es la masturbación compulsiva, siéndole al chico difícil dejar de hacerlo incluso cuando se le señala que no lo haga. Muchas veces se convierte en su principal interés, desplazando al juego o la escuela. También deben llamar la atención los juegos sexuales con pares, que utilice palabras o frases sexualizadas infrecuentes para su edad o el que repita movimientos que simulan el acto sexual.

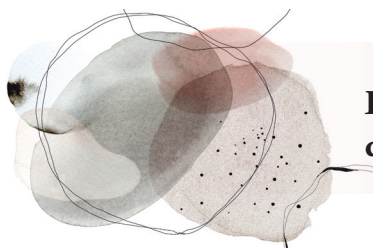
B) Las señales “encubiertas”

Dolores recurrentes sin causa aparente	Por ejemplo, cefaleas, dolores articulares, en la zona abdominal, al tragar o en el pecho.
Cambios bruscos en el apetito	Voracidad o restricción alimentaria, aumento o descenso brusco de peso. Incluso puede manifestarse una anorexia o bulimia.
Conductas regresivas en general	Expresan la búsqueda de “regresar” a las edades en las que los niños y las niñas se sentían estables, confiados y seguros, manifestándolo, por ejemplo, en la pérdida durante el día o la noche del control de la vejiga (enuresis) o del esfínter anal (encopresis).
Manifestaciones emocionales	Como llantos frecuentes o ante cuestiones aparentemente sin importancia, enojos desmedidos, miedos que no estaban, falta de la capacidad de frustración de cosas que antes toleraba.
Cambios en el sueño	Con más miedos nocturnos o pesadillas.
Temores o rechazos	Ocurren frente a ciertas personas y a los ojos de los otros pueden parecer como inexplicables. Pueden manifestarse en frases como “no quiero ir a la casa del tío” o “el abuelo me molesta”.

Ansiedad, depresión y angustia	Como consecuencias a largo plazo vinculadas con aquellas, pueden aparecer las autolesiones e incluso los intentos de suicidio.
Conductas de aislamiento o ensimismamiento	Dejar de relacionarse con chicas y chicos de su edad. Muchas veces, el agresor intenta aislar a sus víctimas no solo porque suele ser posesivo, sino como una forma de resguardar el secreto. Pero, a su vez, las mismas pueden empezar a sentirse diferentes de sus compañeros, "sucios", y buscan aislarse.
Disminución en el rendimiento cognitivo y baja en el académico	El abuso irrumpe de tal manera en el psiquismo que desplaza otros intereses, como el juego o el estudio.
Sobreexcitación	Estar en movimiento todo el tiempo, con disminución de los periodos de atención.

¿Cómo iniciar la charla en el consultorio con un adolescente que podría estar sufriendo abuso o lo ha sufrido?

En todos los casos se deben tomar los recaudos necesarios para proteger a la víctima y procurar que reciba una contención y atención inmediata.

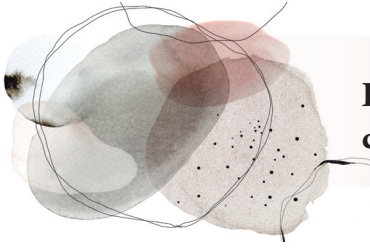


Es un delito de denuncia obligatoria y, por lo tanto, debemos dar intervención a la Justicia.

La detección de un caso de abuso sexual contra un adolescente puede darse en distintos ámbitos y en algunos casos involucra a adultos que no forman parte de su familia, a docentes, instructores de deportes, psicólogos, pediatras, entre otros profesionales. Puede ocurrir tanto que la chica o el chico revele la violencia a través de su relato, como que se detecten indicios que habiliten la sospecha. En todos los casos y tal como señalamos, conocer cómo proceder resulta fundamental.

Un punto central a tener en cuenta y que se destaca en la guía de buenas prácticas de Unicef (2013) para actuar frente a estos casos es que "ninguna persona tiene que transformarse en una experta o hacerse cargo de abordar la totalidad de la situación. Sí debe saber que **su rol –abrir un camino para poner fin al abuso y generar la posibilidad de una atención– en sí mismo tiene un efecto reparador**. Esto implica reconocer que no somos quienes vamos a resolver el caso, pero sí podemos hacer una gran diferencia.

Si **el adolescente que sufrió abuso sexual está acompañado por un adulto protector** al momento de la revelación, o si es el adulto el que se acerca por su cuenta para contarnos lo ocurrido, las preguntas deben dirigirse exclusivamente a este último (resguardando al adolescente y evitando hacerlo en su presencia) y en los siguientes términos: "¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Quién lo hizo?"

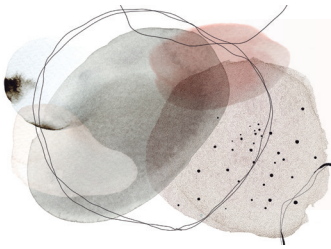


Los adolescentes no deben ser interrogados bajo ninguna circunstancia.

Si la develación ocurre en un consultorio, escuela o comisaría se debe permanecer en **un lugar seguro, resguardado**, acompañados por un profesional específicamente preparado para atenderlos y contenerlos, sin posibilidades de cruzarse con otras personas ni escuchar el relato que hace al adulto responsable.

Debemos recordar que el testimonio de la víctima debe ser tomado, lo antes posible, por profesionales específicamente capacitados en esta temática, idealmente una sola vez y en un espacio preparado para tal fin. Tener presente que, si los profesionales del equipo de atención no están interiorizados, no deben preguntar, especialmente porque muchas veces contaminan el relato o presionan a la víctima con preguntas.

En caso de que la chica o el chico estén solos se deberá escucharlos sin interrupciones ni valoraciones respecto del relato, permitiendo que se expresen.



Se deberá tomar registro escrito textual y completo de lo que contó sin hacer intervenciones y poniendo sus dichos entre comillas.

Sería deseable conocer los siguientes ítems, a partir del relato espontáneo:

- ¿Cuándo ocurrió el hecho o los hechos?
- ¿Quién o quiénes cometieron la agresión?
- Si dichas personas (agresor/es) pueden volver a establecer contacto con la víctima.
- Fundamentalmente, saber si el agresor convive o si tiene vinculación cotidiana (familiar, vecino, docente, otros).

Si la información no surgiera del relato se guiará al adolescente mediante preguntas precisas como: "¿Cuándo ocurrió?"; "¿Quién fue?"; "¿Esa persona vive en tu casa?" u otras semejantes.

Es clave brindarle confianza, hacerle saber que se lo acompañará y no demostrar alarma por lo que se escucha. Se deberá identificar un adulto protector de confianza, de no haberlo se solicitará la intervención de los organismos de Defensa de Derechos, también se podría requerir una internación hospitalaria como medida de cuidado.

Resumen que establece la Guía de buenas prácticas de UNICEF para actuar frente a estos casos es:

- En todos los casos se debe dar intervención a la Justicia además de procurar que la o el adolescente reciba asistencia inmediata.
- La develación del hecho puede ocurrir en distintos organismos y situaciones.
- El adolescente puede hacerlo solo o acompañado de un adulto de confianza.
- Si se presenta acompañado, las preguntas deberían ser dirigidas al adulto y al adolescente resguardarlo (no en su presencia para no contaminar el relato).
- Si se presenta solo, se deberá intentar identificar a un adulto responsable y de confianza del adolescente. Debemos recordar que si viene solo es posible que no haya un adulto de confianza y debemos realizar nosotros tanto la denuncia como la notificación a organismos de protección de derechos.
- El adolescente no debe ser interrogado en ninguna circunstancia, más allá de la obtención de alguna información mínima, que en principio debe ser procurada a través del adulto.
- Se debe asegurar que el adolescente espere y sea atendida en un lugar adecuado, sin posibilidades de cruzarse con otras personas ni escuchar el relato que hace el adulto responsable.

Si un adolescente, de quien sospechamos que es víctima de abuso sexual o quien nos devela concretamente que lo es, nos pidiera mantener la confidencialidad y no denunciar o implementar medidas de protección, **no podemos hacerlo**, ya que estaríamos exponiéndolo a que continúe el abuso y en general el temor de la víctima va en dirección de proteger al abusador.

Si la sospecha se funda en cambios conductuales o en otras observaciones que nos permitan estimar que está sufriendo algún tipo de abuso, sugerimos:

- Tratar de habilitar el diálogo con un acercamiento tranquilo, en un ámbito privado, sin exponerlos.
- No buscar calmar la propia curiosidad o angustia, sino generar un canal de comunicación.

Por eso recomendamos realizar preguntas indirectas, como: “Te noto triste, ¿te ocurrió algo que te esté preocupando?”. También podemos hacer otras más concretas a partir de aquello que nos llama la atención, por ejemplo: “Te veo rara desde la última vez que te vi. ¿Pasó algo que quieras contarme?”.

Si el adolescente no puede contar nada o si se repliega más, no debemos insistir con preguntas. Es importante mostrarse comprensivo y decirle que puede confiar en nosotros, que, si no quiere hablar y contar en ese momento está bien, que puede hacerlo cuando quiera, que siempre vamos a estar ahí para escuchar.

Si la sospecha es por lesiones en la zona genital o por otros indicadores directos, podemos iniciar diciendo frases como “creo que algo te está pasando y puedo ayudarte”, es importante transmitirle que entendemos que le cueste hablar y que vamos a buscar ayuda para que esté mejor.

Ante cualquier sospecha relacionada con un posible agresor, lo primero es evitar que el adolescente esté expuesto a esa persona hasta que se esclarezca la situación. Ese acto, además, va a ayudar a habilitar el diálogo, (porque hay un mensaje que fue dado claramente y es que buscamos protegerlo) y es una intervención en sí misma.

Cuando insistimos en aclarar que no deben ser interrogados es porque además de contaminar el relato, muchas veces se revictimiza obligando a repetir una y otra vez. Esto es en sí mismo traumático y por otro lado va envuelto de metamensajes como el descreimiento en la víctima o la minimización de los hechos.

Es recomendable tener identificado los teléfonos a los cuales se debe recurrir como los distintos efectores locales.

A continuación, un cuadro de acciones recomendadas: QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

	Qué hacer	Qué NO hacer
Violación involucra violencia, penetración con objetos o partes del cuerpo, suele haber lesiones.	• Atención médica de urgencia. • Se interna. Revisación médica con dos profesionales de ser posible, toma de cultivos e indicación de kit de prevención de embarazo (si en mujer) y de enfermedades de transmisión sexual (VIH incluido); se investigan drogas en sangre y/o orina de ser posible • Se contiene a la víctima y familiares si está acompañada/o • Se da intervención inmediata a la Justicia, que será la responsable de realizar la investigación. Si el adolescente está acompañado por un adulto responsable, se le solicita que haga la denuncia y se deja copia en la historia clínica. Si no, el médico tiene el deber de realizarla	• Minimizar la situación o considerar el abuso como "sexo brusco consensuado" • No administrar kit de prevención. • Interrogar a la víctima con preguntas como "¿está seguro/a que no quisiste tener sexo?", "¿es tu pareja?", etc. • No realizar la denuncia o no constatar que el familiar la realizó dejando copia en la historia clínica
Sospecha de abuso sexual a un adolescente por indicadores directos (embarazo, enfermedades de transmisión sexual, lesiones, hipersexualidad etc.)	Si viene acompañado de adulto: • Atención médica de la condición y tratamiento de ser necesario. • Se realiza la entrevista sólo al adulto. Es importante determinar el riesgo de que continúe siendo víctima de abuso sexual. • Se le solicita al adulto protector que realice la denuncia y notificación a organismo de protección de derechos, de no hacerlo deberá hacerla el médico interviniente. Si viene solo: • Atención médica de la condición y tratamiento de ser necesario. • Dejar relato espontáneo. Sólo si la información no surgiera del relato, se guiará al adolescente mediante preguntas precisas como: "¿Cuándo ocurrió?"; "¿Quién fue?"; "¿Esa persona vive en tu casa?" • Contener, transmitirle que lo ayudaremos. • Realizar la denuncia y proveer medidas de resguardo.	Si viene acompañado de adulto: • No administrar tratamiento o "canjearlo" por la denuncia (es abandono de persona). • Interrogar al NNyA. • Interrogar al adulto o NNyA en presencia del otro. • No verificar que se haga la denuncia o no realizarla. Si viene solo: • No dar la atención médica. • Interrogarlo con preguntas directas: "¿por qué no dijiste nada antes?", poner en duda sus dichos o buscar contradicciones, alarmarnos y mostrar temor, curiosidad, buscar satisfacer nuestra ansiedad. • No realizar la denuncia. • No proteger al NNyA.

	Qué hacer	Qué NO hacer
Si viene acompañado de un adulto y la sospecha es del adulto o del pediatra, docente u otro:	• Para poder entrevistar al adulto acompañado el adolescente debe estar en otra dependencia acompañado de un profesional o persona idónea. • Al adulto permitirle hacer relato espontáneo, luego si no surge del mismo debemos saber: ¿Cuándo?, ¿dónde? ¿Quién es presumiblemente el abusador/es? si puede tener contacto con la víctima o no. • Se debe solicitar que realice la denuncia, y notificación a organismos de derechos. Deberá traer copia para ser guardada en la historia clínica. • Se le explica que el adolescente deberá ser revisado por un profesional y posiblemente tomar muestras de cultivos y tratamiento pertinente. • En lo posible es deseable que reciba apoyo psicológico a la brevedad. • Se escribe como diagnóstico "sospecha de abuso sexual" pero se procede como si se tuviese la certeza. Si viene solo: • La primera entrevista es clave por ser la menos "contaminada" de realizarse adecuadamente. • Saber qué hacer y qué NO hacer. • Realizar la entrevista en un lugar apropiado, respetando la intimidad y privacidad del adolescente. • Generar un clima adecuado para establecer un buen vínculo. Pueden estar acompañados por adulto si lo desean (preferiblemente no porque, no sabemos si es parte, cómplice etc.). • Contener, transmitirle que lo ayudaremos. • Explicarle que se le realizará una revisión médica para asegurarnos de su bienestar. Realizar la denuncia y proveer medidas de resguardo (incluso puede ser internado).	Si viene acompañado de un adulto y la sospecha es del adulto o del pediatra, docente u otro: • Realizar entrevista estilo indagatoria delante del adolescente. • Pedir detalles, hacer inferencias o buscar datos que solo satisfacen la propia curiosidad. • No tomar entrecorillado los dichos textuales de lo expresado en torno a la situación que plantea sospecha. • No avisar que debe ser revisado, tomar fotos o cultivos. • Enviar al NNYA a su casa sin constatar si el sospechoso perpetrador es conviviente. • No dar intervención a organismos de derechos ni realizar la denuncia. Si viene solo: • Contaminar el relato con preguntas como "¿fue tu abuelo?", "¿seguro no fue tu papá?", entre otras. Es necesario formular preguntas abiertas que le permitan generar un relato libre. Sólo cuando el relato haya finalizado, se inicia la fase de preguntas focalizadas que deben partir de la información previamente brindada por el niño. • Introducir preguntas que mencionen datos que NO han sido mencionados por el niño. • Prometer "soluciones" que no podemos garantizar. • No realizar la revisión médica y ginecológica cuando es necesaria, con los cultivos y el tratamiento adecuado. • No realizar la denuncia.

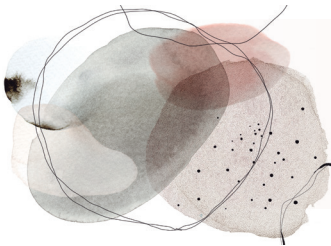
Fuente: Tomado de Manual de Buenas Prácticas UNICEF y Protocolo Interdisciplinario Unificado del Hospital de Clínicas José de San Martín UBA.

TRATAMIENTOS DE EMERGENCIA EN ABUSO SEXUAL

¿Cuáles son las intervenciones de emergencia en abuso sexual infantojuvenil?

El manejo de emergencia en casos de abuso sexual se enfoca en:

- La prevención.
- El diagnóstico y el tratamiento oportuno de lesiones.
- En las infecciones de transmisión sexual.
- Profilaxis contra el VIH.
- La administración de vacunas.
- La implementación de medidas esenciales como la anticoncepción.



Este abordaje integral es fundamental para reducir el riesgo de secuelas infecciosas y garantizar la salud integral del niño, niña y adolescente (NNyA).

Los pediatras, deben estar preparados para efectuar intervenciones que incluyan estudios diagnósticos, la administración temprana de tratamientos empíricos y el seguimiento clínico riguroso.

La presencia de lesiones y traumatismos genitales por relaciones sexuales forzadas incrementan aún más las probabilidades de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La prevalencia de ITS en víctimas de abuso depende de varios factores: el tipo de exposición, la presencia de signos o síntomas, el número de atacantes, etc.

El tratamiento de emergencia en situaciones de abuso sexual debe asegurar:

- Anticoncepción hormonal de emergencia (AHE).
- Antibióticos para prevenir infecciones de transmisión sexual.
- Antirretrovirales.
- Vacunas.

¿Qué estudios se deben solicitar?

Laboratorio basal

- Hepatograma y pruebas de función renal.
- Pruebas toxicológicas en caso de sospecha de intoxicación por drogas.
- Test de embarazo en orina o sangre.
- VIH: ELISA 4a generación.
- Hepatitis B: AgHBs, anti-HBc, Anti-HBs (para evaluar vacunación previa).
- Hepatitis C: ELISA.
- Pruebas treponémicas de diagnóstico rápido si están disponibles o VDRL.

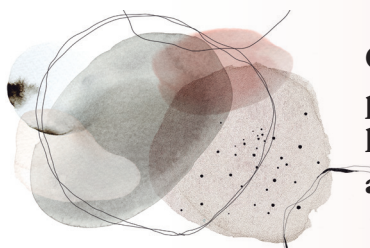
Estudios serológicos: los test que se realizan al ingreso revelan solo exposición previa a ITS y no realizan diagnóstico en la exposición actual, por lo cual deberán ser reiterados en controles posteriores a las 4 semanas, 3 y 6 meses.

Microscopía directa, cultivo y PCR

Es importante el período de incubación de los patógenos para decidir el momento de toma de muestras en niños/niñas prepúberes.

- **Si el abuso ha ocurrido en un plazo menor de 48 horas**, previo a la consulta, se recomienda hacer profilaxis para gonorrea. En este período el cultivo para *Neisseria gonorrhoeae* puede ser negativo, aunque exista infección.
- **Cuando el abuso ha ocurrido en un plazo mayor a 48 horas**, previo a la consulta, las opciones pueden ser: tratar a todos los niños en forma profiláctica o pedir exudado genital, anal y faríngeo y esperar el resultado del cultivo.

Las pruebas para *Chlamydia trachomatis*, *Trichomonas vaginalis* y vaginosis bacteriana se deben realizar **2 semanas después** del incidente si no hubiera recibido profilaxis.



Cultivos positivos para *N. gonorrhoeae* y/o la serología positiva para sífilis o VIH se consideran indicativos de abuso, habiendo descartado la infección de transmisión perinatal de acuerdo a la edad del paciente, en el caso de estas dos últimas.

¿Cómo se toman las muestras?

• Sospecha de infección gonocócica

En niñas prepúberes, la manifestación más frecuente es la vaginitis. Las infecciones anorectal y faríngea suelen ser asintomáticas, por lo que no se realizan tomas de muestras endocervicales sino muestra vulvar y vaginal. En presencia secreción uretral y/o anal recoger la muestra con hisopo de dacrón o rayón y enviar al laboratorio para procesar inmediatamente, de lo contrario debe enviarse en medio de transporte (Stuart o Thayer Martin).

La muestra de primer chorro de orina en hombres es útil cuando no hay secreción, en mujeres presenta baja sensibilidad por lo que no se recomienda.

- Coloración de Gram: tiene una especificidad >99% y una sensibilidad >95% en secreciones uretrales de varones sintomáticos. En varones asintomáticos, no es útil para descartar la infección en ese grupo de pacientes debido a una menor sensibilidad.

No se recomienda el estudio aislado por técnica de Gram en muestras de faringe y recto ya que pueden dar resultados confusos por la presencia de flora saprófita.

- Cultivo: método de elección para el diagnóstico de lesiones extragenitales. Además, permite el estudio de la sensibilidad antibiótica en caso de ser necesario.

- Técnicas moleculares - Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT): puede realizarse en muestras de orina (primera fracción de 10 ml) e hisopado vaginal de niñas prepúberes. NO debe usarse en muestras de orina de varones prepúberes.

- **Sospecha de infección por *Chlamydia***

La infección por *Chlamydia trachomatis* en niño/as prepúberes requiere una evaluación multidisciplinaria para descartar abuso sexual infantil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la infección perinatal puede persistir durante los 2 a 3 primeros años de vida.

C. trachomatis es una bacteria intracelular, por lo tanto, la muestra debe asegurar un alto contenido de células.

Se debe eliminar todo tipo de exudado presente previo a la toma de la muestra. La detección puede realizarse mediante:

- Técnicas moleculares (NAAT): en muestras de orina y vagina de niñas prepúberes. No debe realizarse esta técnica en muestras de orina de varones prepúberes ni en lesiones extragenitales.
- Cultivo: método de elección en muestras urogenitales de varones prepúberes y muestras extragenitales de ambos sexos.

Emplear hisopos delgados de dacrón o rayón en tubo seco. No se debe tomar muestras con hisopos de algodón o con palillo de madera.

- **Sospecha de infección por *Trichomonas vaginalis*:** solo debe realizarse hisopado vaginal.

¿Cómo realizar profilaxis en Infecciones de Transmisión Sexual?

En diversos entornos no es posible realizar pruebas para ITS, ya sea porque no se dispone de pruebas o porque es poco probable que acudan nuevamente para recibir atención, en estas situaciones es propicio realizar profilaxis post exposición en los siguientes ítems:

- Profilaxis antibacteriana y parasitaria.
- Profilaxis anti-hepatitis B.
- Profilaxis VPH.
- Profilaxis antitetánica.

Tabla 1. Profilaxis antibacteriana recomendada en contextos de urgencia

Niños y Niñas (< 45 kg)	Adolescentes (≥ 45 Kg)
Ceftriaxona 250 mg IM - dosis única o Cefixima 8 mg/kg VO - dosis única (máximo 400 mg) +	Ceftriaxona 500 mg IM - dosis única o Cefixima 400 mg - dosis única +
Azitromicina 20 mg/kg/dosis VO - dosis única (máximo 1 gr) +	Azitromicina 1 g VO -dosis única o Doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días +
Metronidazol 15 mg/kg/día VO cada 8 h por 7 días	Metronidazol 2 g VO - dosis única

- **Profilaxis antibacteriana y parasitaria**

- Antibacteriana: *N.gonorrhoeae* y *C. trachomatis*.
- Antiparasitaria: *T. vaginalis*.

- **Profilaxis anti-hepatitis B**

La profilaxis para VHB demostró ser **eficaz hasta los 7 días post exposición (mayor rango de eficacia en las primeras 72 horas)**. Es por ello que se podrá esperar el resultado de la serología para adoptar una conducta:

- Antecedente de vacunación completa: no es necesario tomar conducta activa.
- Antecedente de vacunación incompleta: completar esquema. Conducta posterior de acuerdo al resultado de serología solicitada.
- Sin antecedentes de vacunación o desconocida: administrar una dosis de vacuna y completar esquema de 3 dosis.

Conducta posterior de acuerdo al resultado de serología solicitada. La inmunoglobulina se indicará en caso de certeza de que el agresor presente AgHBs +.

- **Profilaxis VPH**

No hay evidencias que la vacuna para el VPH como profilaxis modifique el curso de una potencial infección. En la Argentina se incorporó al calendario oficial la vacuna a partir del año 2000 en las niñas y 2006 en los niños. Actualmente se indica 1 dosis, excepto en pacientes inmunocomprometidos que se prescriben 3 dosis.

- **Profilaxis antitetánica**

Debe considerarse la oportunidad para iniciar o completar esquemas.

¿Cuáles son los criterios para indicar profilaxis para VIH?

Se debe **realizar la profilaxis para VIH posterior a la exposición si la agresión sexual ocurrió dentro de las 72 horas antes de la consulta**. Si fueron múltiples incidentes, debe considerarse el más reciente.

Se indicará profilaxis cuando NN y/o A han sido agredidos con penetración oral, vaginal o anal o cuando ha estado expuesto a sangre o semen a través de heridas u otras membranas mucosas, recordando que la relación es en general traumática, provocando lesiones que aumentan la posibilidad del contagio.

La **profilaxis debe iniciarse dentro de las 2 horas y hasta un máximo de 72 horas desde el abuso**. Si se conoce la fuente y resulta negativa para VIH, habiendo asegurado que el abusador no se encuentre en período ventana, se suspende la profilaxis en ese momento. En caso contrario se mantiene por 4 semanas.

La profilaxis reduce las probabilidades de contraer la infección por el VIH, pero no es 100% eficaz. Para aumentar la adherencia y seguimiento, se debe proporcionar la medicación hasta la consulta con especialista en infectología.

Tabla 2. Esquemas disponibles recomendados para profilaxis para VIH pos-exposición

Edad	Preferido	Alternativo
> 12 años	TDF/3TC o FTC + DTG	TDF/3TC o FTC + RAL ≥40 kg: TDF/3TC o FTC + DRV/r (800/100) cada 24 h
6-12-años	TDF/3TC o FTC + DTG	AZT/3TC + RAL o TDF/FTC ≥ 40 kg: TDF/3TC o FTC + DRV/r (800/100) cada 24 h
3 a 6 años	AZT/3TC + RAL TDF/3TC	Considerar como tercera droga DTG
1 mes a 3 años	AZT/3TC + RAL	AZT/3TC + DTG

Fuente: Adaptado de Actualización 2021 del VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral-SADI. Notas: TDF: tenofovir disoproxil fumarato, 3TC: lamivudina, DTG: dolutegravir, FTC: emtricitabina, DRV/r: darunavir/ritonavir, AZT: zidovudina, RAL: raltegravir

¿Cómo se implementa la anticoncepción hormonal de emergencia?

La anticoncepción hormonal de emergencia (**AHE**) puede iniciarse inmediatamente posterior a la exposición, o hasta 5 días después de la misma. La eficacia de la AHE aumenta cuanto más pronto se tome después de la relación sexual.

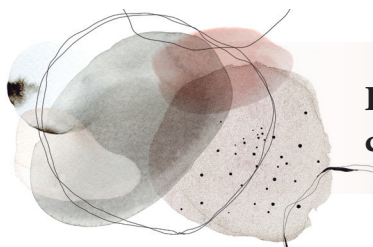
Dentro de las **primeras 12 horas la eficacia es del 95% y disminuye al 52% en los 5 días** posteriores a la relación sexual sin protección. Los efectos secundarios de la medicación son leves y su duración no se extiende más de 24 horas.

Tabla 3. Anticoncepción de emergencia - Personas mayores de 8 años post violación sexual

Levonorgestrel 1,5 mg	1 sólo comprimido de 1,5 mg
Levonorgestrel 0,75 mg	2 comprimidos de 0,75 mg toma única

Fuente: Adaptada de Recomendaciones para la Profilaxis Post Exposición para VIH, ITS y anticoncepción. Año 2022.

¿Cómo efectuar el seguimiento de los pacientes?



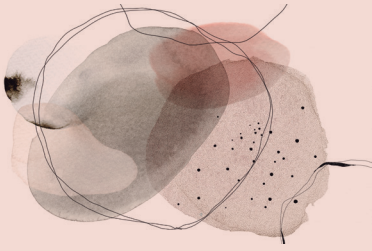
Luego de una situación de abuso sexual debe realizarse controles periódicos.

El tiempo posterior al hecho y los estudios a realizar se plantean en **Tabla 4.**

Tabla 4. Controles periódicos ante una situación de abuso sexual

Plazo	Controles a realizar
2 semanas	Hemograma, función renal y hepatograma (si se inició Profilaxis ARV). Ante ausencia de menstruación se repetirá la subunidad Beta de GCH entre la 2° y 6° semana
4 semanas	Serología para VIH, métodos rápidos treponémicos o VDRL, antiHBc, AgHBs, antiHBs, hepatitis C. Vacuna antiHBV si inició esquema en la primera consulta. HMG y hepatograma al completar profilaxis para VIH. Test de embarazo en caso de retraso menstrual.
3 meses	Serología para VIH, VDRL, antiHBc, AgHBs, antiHBs, hepatitis C
6 meses	Serología para VIH, métodos rápidos treponémicos o VDRL, antiHBc, AgHBs, antiHBs, hepatitis C, Vacuna antiHBV

ARV: antirretrovirales- GCH: Gonadotrofina Corionica humana-



Autoevaluación

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

	V	F
1. En la mayoría de los casos, los agresores son varones que pertenecen al entorno familiar y social próximo.	☐	☐
2. Los comentarios sexualizados hacia los adolescentes o exponerlos a pornografía son considerados abuso sexual.	☐	☐
3. La mayoría de los abusos sexuales son violentos y dejan marcas corporales.	☐	☐
4. Siempre se da una asimetría de poder ya sea en términos de fuerza física, económicos, emocionales, sociales o en relación con la diferencia de edad, roles o capacidad de manipulación psicológica.	☐	☐
5. Es un delito de denuncia obligatoria y, por lo tanto, se debe dar intervención a la Justicia.	☐	☐
6. El relato del adolescente debe ser resumido por el profesional al finalizar la entrevista.	☐	☐
7. Los cultivos positivos para <i>N. gonorrhoeae</i> y/o la serología positiva para sífilis o VIH se consideran indicativos de abuso (habiendo descartado la infección de transmisión perinatal).	☐	☐
8. La profilaxis para VIH debe iniciarse dentro de las 2 horas y hasta un máximo de 72 horas desde el abuso.	☐	☐
9. Para la atención en la emergencia debe solicitarse al adulto acompañante la realización de la denuncia correspondiente.	☐	☐
10. En la primera consulta, es importante indicar tratamiento contra las ITS.	☐	☐

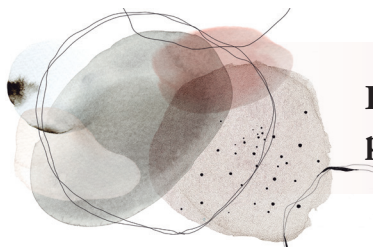
II. Enumere por lo menos tres señales evidentes de abuso sexual y tres señales encubiertas.

.....

.....

CONCLUSIONES

Los abusos sexuales en los que adolescentes son víctimas constituyen una problemática que tanto por su prevalencia como por los daños posibles en las víctimas requiere del conocimiento de sus manifestaciones y de los procedimientos a realizar para minimizar el impacto y favorecer una recuperación saludable.



La mayoría de los abusos son intrafamiliares o perpetrados por figuras de cuidado del entorno cercano.

En cuanto a el abuso es perpetrado por otro adolescente, el impacto y las formas de presentación de esa conducta sexual dañina es difícil de estimar, ya que la conducta problemática, abusiva y violenta puede pasar en gran medida desapercibida por una variedad de razones, una de ellas es la naturalización de consumo de material pornográfico que termina incidiendo negativamente en los adolescentes.

Las investigaciones también indican que entre el 90% y el 97% de los jóvenes que tienen conductas sexuales nocivas son varones y que el inicio de estas conductas suele producirse en la adolescencia temprana, cuando viven con sus familias.

En ningún caso se debe exigir al paciente la denuncia a las autoridades como requisito para su atención.

Con el fin de reducir la revictimización del paciente, se debe reducir el número de entrevistas y el número de entrevistadores debería ser el mínimo.

Ofrezca tratamiento contra las ITS en su primer encuentro.

Si no se dispone de pruebas o no parece probable que el NNy/oA regrese, se iniciará tratamiento por manifestaciones sincrónicas.

Considerar la profilaxis post exposición para VIH en pacientes con Abuso Sexual dentro de un plazo de 72 horas, ante las siguientes situaciones: ITS concomitante, Injuria de mucosa con sangrado, agresor con factores de riesgo para VIH o múltiples atacantes.

Realizar siempre la consulta al especialista en enfermedades infecciosas.

Las respuestas esperables no pueden reducirse solo a lo punitivo, por eso reclama también la capacitación para poder dar oportunidades a las personas en crecimiento y maduración.

LECTURAS RECOMENDADAS

Abordaje

- Ongini S, Gandara V, Steverlynk D, Ayuso M. (2021). Romper el Silencio: por infancias y adolescencias libres de violencia sexual. Buenos Aires. Editorial DAO.
- Unicef. Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, Protección de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. 2013. 1ª Edición.
- Valente, S., Ongini, S. y Tempone, D. El superpoder de la educación sexual. Herramientas que pueden cambiar destinos. 2020. Buenos Aires. Ed. DAO.
- Hailes HP, Yu R, Danese A, Fazel S. Long-term outcomes of childhood sexual abuse: an umbrella review. Lancet Psychiatry. 2019; 6 (10): 830-839.
- Toporosi, S. En carne viva. 2018. Buenos Aires: Editorial Topía.

Tratamiento en la emergencia

- Gaiano A. Infecciones de Transmisión sexual en niños, niñas y adolescentes. Libro Azul de Infectología pediátrica. Sociedad Argentina de Pediatría. 5ª Edición. 2022.
- Cuello A, Fridman V y col. Recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual de la Comisión de HIV/SIDA y de ITS de la Sociedad Argentina de Infectología 2020.
- Red Book. American Academy of Pediatrics. Sexual Assault and Abuse in Children and Adolescents. 32 Edition 2021-2024.
- Cómo responder a niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual. Directrices clínicas de la OMS. Ginebra, Organización Panamericana de la Salud, 2020.
- Sociedad Argentina de Infectología-SAD. Actualización 2021 del VII Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral / 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Sociedad Argentina de Infectología, 2022.
- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales. Recomendaciones para la Profilaxis Post Exposición para VIH, ITS y anticoncepción. Año 2022.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. La inmensa mayoría de las veces los abusos no dejan marcas en el cuerpo.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. Se deberá tomar registro escrito textual y completo de lo que contó sin hacer intervenciones y poniendo sus dichos entre comillas.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Falso. En ningún caso se debe exigir al paciente la denuncia a las autoridades como requisito para su atención.
10. Verdadero.

II. Enumere por lo menos tres señales evidentes de abuso sexual y tres señales encubiertas.

Señales más evidentes: embarazo, dolor al sentarse o al ir al baño, manchas en la ropa interior, infecciones genitales o de transmisión sexual, conductas hipersexualizadas.

Señales encubiertas: dolores recurrentes sin causa aparente, cambios bruscos en el apetito, conductas regresivas en general, manifestaciones emocionales, alteraciones en el sueño, temores o rechazos, ansiedad, depresión y angustia, aislamiento o ensimismamiento, disminución en el rendimiento cognitivo y baja en el académico, sobreexcitación.

